

AI 驱动 药物 发现 平台 + 数据 驱动 平台 强强 联合

Recover 平台 × Genesis_Medicine v3

2026-04-26

强强 联合 — Recover 平台 + Genesis_Medicine v3

1. 强强 联合

Recover 平台 与 Genesis_Medicine v3 平台 强强 联合, 结合 AI 驱动 药物 发现 平台 与 数据 驱动 平台, 共同 推动 药物 发现 进程, 提升 药物 发现 效率。

强强 联合

1. AI 驱动 药物 发现 平台 — 结合 AI 驱动 药物 发现 平台 与 数据 驱动 平台, 共同 推动 药物 发现 进程, 提升 药物 发现 效率。
2. AI 驱动 药物 发现 平台 → 数据 驱动 平台 — 结合 AI 驱动 药物 发现 平台 与 数据 驱动 平台, 共同 推动 药物 发现 进程, 提升 药物 发现 效率。
3. 数据 驱动 平台 — Embelin scaffold-hopping 平台 结合 EMB-3 (hERG 0.16, MD 0.79 Å, 平台 + IPF 6/7 平台 binding) 平台 共同 推动 药物 发现 进程, 提升 药物 发现 效率。

强强 联合

- 2026-08: Recover 平台 平台 平台 (平台 平台 平台)
- 2026 Q4: 平台 平台 EMB-3 in vitro CRO 平台 (¥1,560)
- 2027: 平台 IND 平台 (平台)

2. 2025 年 (2024 年?)

2.1 2025 年

- 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年: 2025 年 ₩4.2 兆 (2024 年 12% 増)
- 2025 年 **anti-fibrotic** 2025 年: 2030 年 \$35B (IPF·NASH·2025 年 2025 年)
- **K-beauty + K-medicine** 2025 年: 2025 年 + AI 2025 年 2025 年
- 2025 年 2025 年: Insilico Medicine 2025 年 **Rentosertib** (TNIK 2025 年) — 2025 年 generative AI 2025 年, 2025 年 IPF Phase 2a 2025 年 (FVC +98.4 mL). 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 = 2025 年 2025 年

2.2 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年

- KP/KHP 12 2025 年 514 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年
- KIOM (2025 年 2025 年) OASIS, 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年
- 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年 — Genesis_Medicine v3 2025 年 2025 年
- BOKP DNA barcode (Frontiers Pharmacol 2024) — 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年

2.3 AI 2025 年 2025 年 2025 年 2025 年

- NIPA 2025 年 2025 年: “2025 年 **AI** 2025 年 + 2025 年 2025 年”
- Recover 2025 年: 2025 年 2025 年 2025 年 + AI 2025 年 2025 年 + 2025 年 2025 年 2025 年 = 2025 年 2025 年
- 2025 年 2025 年 1 2025 年 2025 年 2025 年 (2025 年 2025 年 2025 年 2025 年)

3. 2025 年 2025 年

3.1 2025 年 2025 年 — Genesis_Medicine v3 (14 2025 年 2025 年)

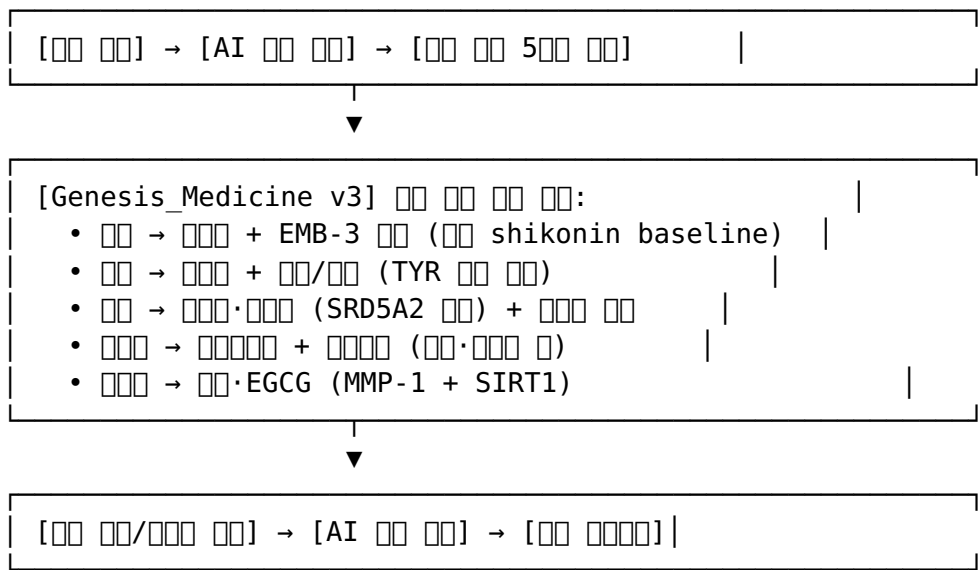
[2025 年] → [2025 年] → [2025 年] → [Cryptic Pocket] → [2025 年] →
[2025 年] → [Cross-Disease] → [De Novo Generation] →
[ADMET 2025 年 2025 年] → [2025 年 2025 年] → [MD] →
[CellAwareGNN 2025 年] → [Cross-Tissue] → [2025 年 2025 年] →
[ABFE 2025 年] → [2025 年 2025 年] → [CRO/IRB 2025 年] → [Manuscript]

2025 年 2025 年 (**commercial** 2025 年): - 2025 年 2025 年: Boltz-2 (MIT), Protenix-v2 (Apache), OpenFold3 (Apache) - ADMET: ADMET-AI 2.0.1 + 2025 年 logKp 2025 年 (FDA 2326) - 2025 年: PocketXMol (Cell 2026, MIT), REINVENT 4, f-RAG with 2025 年 fragment - MD/ABFE: OpenMM 8.5 + openmmtools 0.26 + BAT2 - 2025 年 DB: COCONUT 2.0, NPASS 2026, NPAtlas, KP/KHP, BOKP

3.2 2026-04

	102 (90% +)
	14 (TGF- β 1, MMP-1, CTGF, TYR, MITE, SRD5A2, AR, ...)
5 cofold	$102 \times 14 = 1,428$ run
MD (10 ns)	13 top hit (RMSD < 2 Å)
ABFE ()	EMB-3 vs Embelin $\times$ MMP-1, $\Delta\Delta G$ paper-tier
	6 $\rightarrow$ 9 $\rightarrow$ 102 $\rightarrow$ 14
	EGCG universal (5/5 disease) + EMB-3 multi-tier (IPF cross) – 2 draft

3.3 Recover



3.4

1. IND (, 2027 Q1)
 - EMB-3 (Embelin scaffold-hop) $\rightarrow$ + IPF
 - + EMB-3
2. AI + (, 2026 Q4)
3. + ()
4. ()

4. (12)

	Recover	Genesis_Medicine v3	NIPA
2026 Q3	(8),	Tier 0 SOTA 7	30%
2026 Q4	AI	EMB-3 in vitro CRO Tier 1 (₩1,560)	60%
2027 Q1	200	IND	90%
2027 Q2		EMB-3 Phase 1 entry	100%

5. (+)

	(KRW)	
(AI 2 + 1)	2.4	NIPA 60% + 40%
EMB-3 CRO Tier 1 (KIT/)	0.16	NIPA
(EMB-3 mg scale)	0.05	NIPA
GPU	0.3	NIPA
	0.2	
	0.1	
IND	0.15	NIPA
	3.36	NIPA 2.16 + 1.2

6. (?)

1. — Recover + + AI. .

2. — 14 SOTA. Insilico Medicine.

3. **ABFE** ΔG — Boltz-2 binary classifier IC50 nM . EMB-3 $\times$ MMP-1 ABFE .

4. **Recover** — .

7.

EMB-3 in vitro	30%	lead 4 (EGCG, Embelin, EMB-1, Asiaticoside) backup
IND	20%	OliX OLX104C IND (Phase 1 →)
GPU	15%	RTX 5090 + spot
HERB DB	30%	" + (commercial)

8. ()

- A. Genesis_Medicine v3 GitHub repo (https://github.com/crazat/genesis_medicine)
- B. CLAUDE.md + 14
- C. manuscript 2 draft
 - manuscript_egcg/manuscript.pdf (EGCG 5/5 disease)
 - manuscript_emb3/manuscript.pdf (EMB-3 multi-tier + IPF cross)
- D. CRO (pilot/scaffold_hop/cro_quote/)
- E. (pilot/scaffold_hop/herb_mapping/)
- F. ABFE ()
- G. Recover (<https://recover-clinic.kr>)

9.

AI Recover Genesis_Medicine v3 SOTA , **NIPA 2025** “AI ” .

12 (EMB-3) IND + AI + R&D 1 .

research@recover-clinic.kr 2026-05-31 (NIPA)

△ □ □□ □□□, *NIPA* □□ □□.□□ □□ □□ □□ □□.